

THRESHOLD

THRESHOLD

**За восемь недель находит, какая еда
вызывает симптомы — по клиническому
протоколу, а не по советам.**

Первый протокол из библиотеки. Дальше —
сон, давление, нагрузка.

Протокол, который работает, существует. Проходить его некому

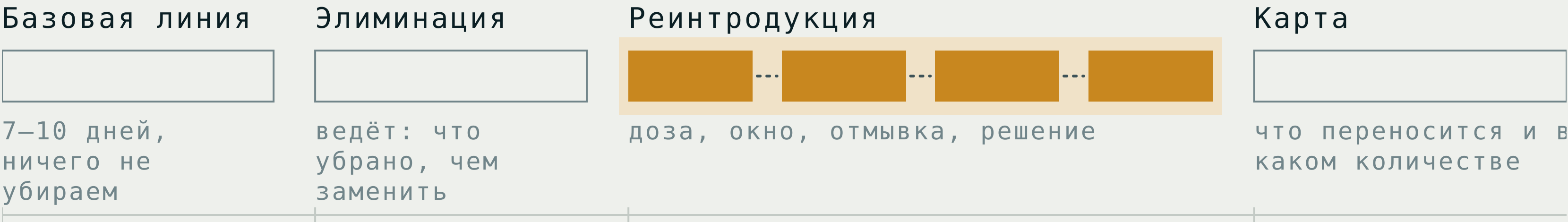
- 15–25 млн взрослых в США. Симптомы годами
- Гуглят, убирают наугад, бросают дневник
- Гайдлайн ACG: диета сложна, нужен подготовленный диетолог
- Диетологов на эту аудиторию не хватает
- Кто начал — застревает на элиминации

Измерять стало бесплатно. Доводить до конца — нет

- OpenAI раздаёт медицинскую память
- Whoop бесплатно принимает любые анализы
- Все выпустили «протоколы» — это план, а не ведение
- Пользователи: данные лежат и ждут
- Их удержание держится на том, что открывать приятно

THRESHOLD

Приложение знает, какой у вас сегодня день протокола



Правило перехода арифметическое. Протокол умеет закончиться выводом «не помогло».

Два года назад это было нельзя построить. Через год позицию займут

- Разложить блюдо на группы стало дешевле
- Голосовой ввод дошёл до нужного качества
- Рынок приучен к ИИ в здоровье — не нами
- Позиция названа, но не занята

Мы это уже построили. Соберём заново — по спецификации

- Команда несколько лет вместе. Система работает в клинике
- Пройдено: сбор из Apple Health, распознавание выписок, память фактов, журнал питания, корреляции
- Движок разворачивает протокол настройкой, а не разработкой
- Пересборка с нуля по функциональной спецификации. Юридическая проверка чистоты — до начала работ

THRESHOLD

\$179 приносит \$155. Вопрос в том, дешевле ли \$63 привести человека

\$155

ВКЛАД С ПРОГРАММЫ

\$188

ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

\$63

ПОТОЛОК САС

- Вклад с программы — \$155 из \$179. Себестоимость \$11,89, резерв на возвраты 7%
- Пожизненная ценность — \$188 в базовом сценарии, \$249 в целевом
- Потолок САС при отраслевом требовании $LTV/CAC \geq 3$: **\$63-83**
- Рынок: 15–25 млн взрослых в США. Ограничение не в размере рынка, а в цене привлечения

Протокол конечен. Продаём не подписку, а очередь протоколов

- Программа — \$179. Восемь недель, карта переносимости, выписка врачу
- Годовой план поддержания — \$149, оплата в момент завершения протокола
- Следующий протокол — снова программа, \$149
- Ключевая метрика: доля перешедших ко второму протоколу
- Позже — тариф со специалистом

Каждый процентный пункт завершаемости стоит \$30 тысяч капитала

- Клиническая базовая линия: 41% доходят до шестой недели — исследование UCLH, 233 пациента, программа с диетологом
- Это приверженность **с** диетологом, но **без** ежедневной поддержки. Базовая линия «если ничего не делать»
- Цель — 51% завершивших протокол. Разница между базовым и целевым сценарием: **\$670k требуемого капитала**
- Хвост продаётся только дошедшим: годовой план, второй протокол, третий
- Это и есть продуктовая задача Threshold. Не «удобнее вести дневник», а «довести до конца»

41% — из одного исследования на 233 пациентах: Mari et al., Eur J Gastroenterol Hepatol, 2019, UCLH. Самоотчётная приверженность на конец шестинедельной программы, не отраслевая константа.

THRESHOLD

Инструменты для записи есть. Очередь никто не ведёт

ИЗМЕРЯЮТ	Function, Whoop, Oura — план, а не ведение
КУРС ИЛИ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	Nerva; Monash — Step 2, дозы, лесенка
ВЕДУТ	Salvo \$127/мес и Sleep Reset — на живых людях
ПРОГРАММНО	только Stellar Sleep, один протокол
ПУСТО	несколько протоколов подряд в одной подписке

THRESHOLD

Не строим, пока не проверим, дешевле ли \$75 привести человека

- Лендинг с реальной оплатой. Две версии цены: \$179 разово против \$20/мес
- **Пороги по САС, объявлены заранее:**

НИЖЕ \$75	идём по плану
-----------	---------------

\$75–150	идём только с проработанным планом органики
----------	---

ВЫШЕ \$150	платный поиск не основной канал, второй этап не тратится на его масштабирование
------------	---

- Критерий чтения A/B: подписка выигрывает только при конверсии **втрое выше**. Двукратный прирост — всё ещё проигрыш по экономике
- 12 интервью проведены. Страница готова
- Дальше: 8 недель сборки, октябрь — стенд с платящими

Четыре риска и механизм по каждому

РАССТРОЙСТВА
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В клинической когорте 23% с риском РПП, и приверженность диете у них **выше**, чем у остальных: 57% против 35%. Метрика роста и главный риск причинения вреда смотрят в одну сторону. Скрининг на входе, правило остановки внутри протокола, отказ обслуживать при срабатывании — в первой версии, не во второй

РЕГУЛЯТОРНЫЙ

Наблюдения, а не утверждения; разбор формулировок под FDA и FTC до включения трафика; юрист до релиза

ПЛАТЯТ ЛИ

Смоук-тест с порогами по САС до разработки

ЛИЦЕНЗИИ НА ШКАЛЫ

В первой версии собственные инструменты

Покупатель платит за данные и канал, а не за выручку

- Фарма с гастроэнтерологическим портфелем — нужны дозозависимые данные по подгруппам FODMAP на тысячах людей
- Консолидаторы цифровой терапии в гастро — покупают возможность, которой у них нет: фазу реинтродукции
- Потребительское здоровье и питание, платформы льгот для работодателей
- Порядок сумм: при выручке \$1–3М с подтверждённым удержанием — \$5–20М. Стратегические покупатели платят на 25–40% больше финансовых
- Что делает компанию продаваемой: регулярная выручка, права на деперсонализированные данные в оферте с первого месяца, измеренный результат на когортах, независимость от основателей

Между кассой и мультипликатором есть противоречие: разовая программа лучше для денежного потока, регулярная подписка — для оценки при продаже. Решение принимается до запуска.

Что нужно, чтобы получить три ответа

Капитал по рубежам. Базовый сценарий, буфер 15%.

РУБЕЖ	ПРИ САС \$75	ПРИ САС \$150
MVP живой, САС известен — мес 5	\$135k	\$227k
+ завершаемость — мес 6	\$135k	\$277k
+ второй протокол — мес 9	\$135k	\$416k

РОЛЬ КОМАНДЫ

- Сборка MVP — фиксированная цена, 8 недель
- Ведение продукта — контракт с минимальным сроком
- Продуктовый лид и рост — отдельная строка бюджета, поверх разработки

ВОРОТА

После смоук-теста, порог по САС. Выше \$150 — второй этап не тратится на масштабирование платного трафика

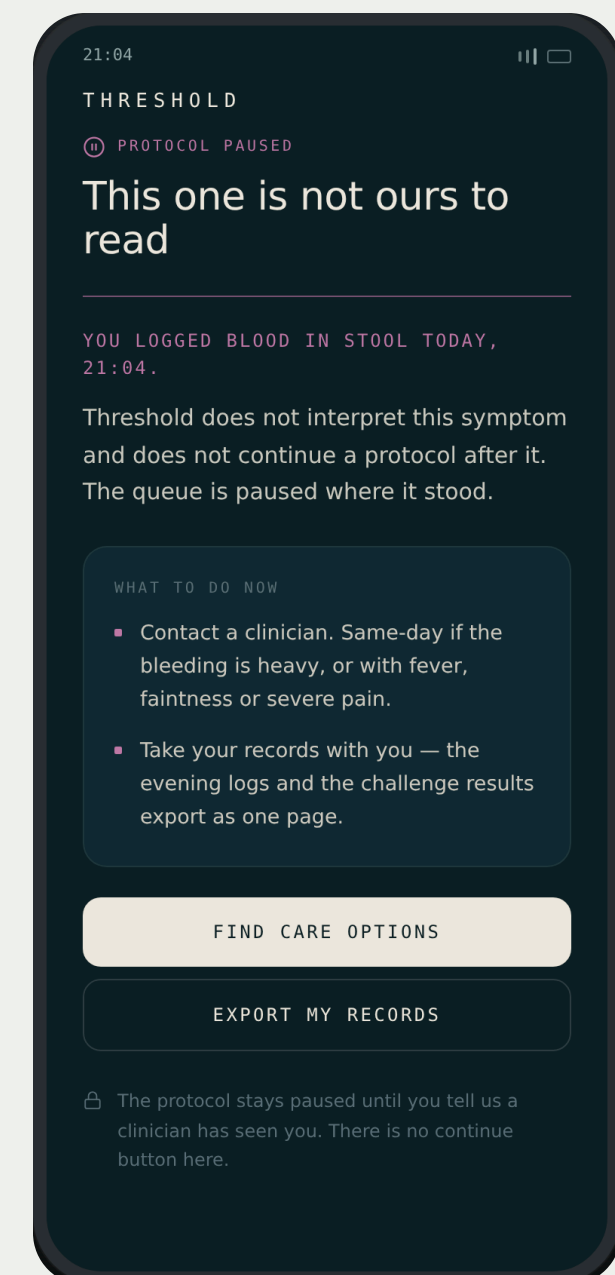
Открытое допущение: стоимость команды после запуска качает требование к капиталу от \$135k до \$2,5М. Это известная неопределённость, а не посчитанная цифра. Горизонт — 36 месяцев: на 18 месяцах модель систематически занижает бизнес, хвост выручки приходит позже.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Красные флаги и критерии исключения протокола

Протокол останавливается сам и не предлагает обходного пути: кровь в стуле, непреднамеренная потеря веса, симптомы, будящие ночью, дебют после пятидесяти.

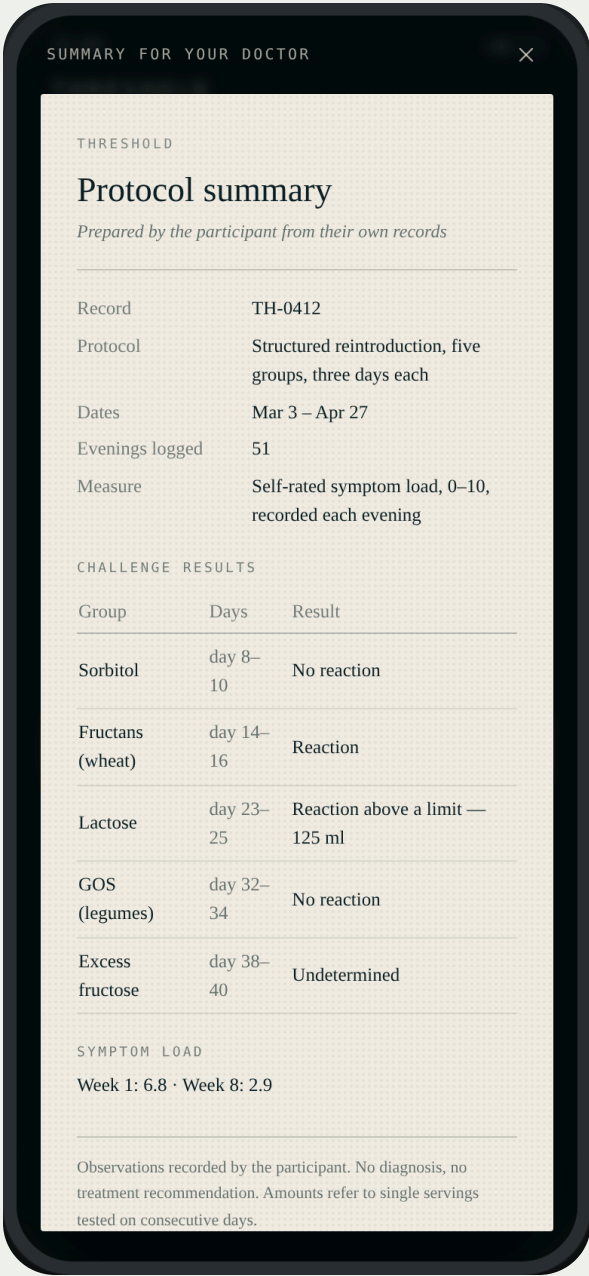
Экран не интерпретирует симптом и не ставит диагноз — он останавливает очередь и отправляет к врачу.



Экран прототипа с выпиской для врача

Одна страница: протокол, даты, результаты челленджей по группам и динамика симптомов в тех же единицах, что человек отмечал каждый вечер.

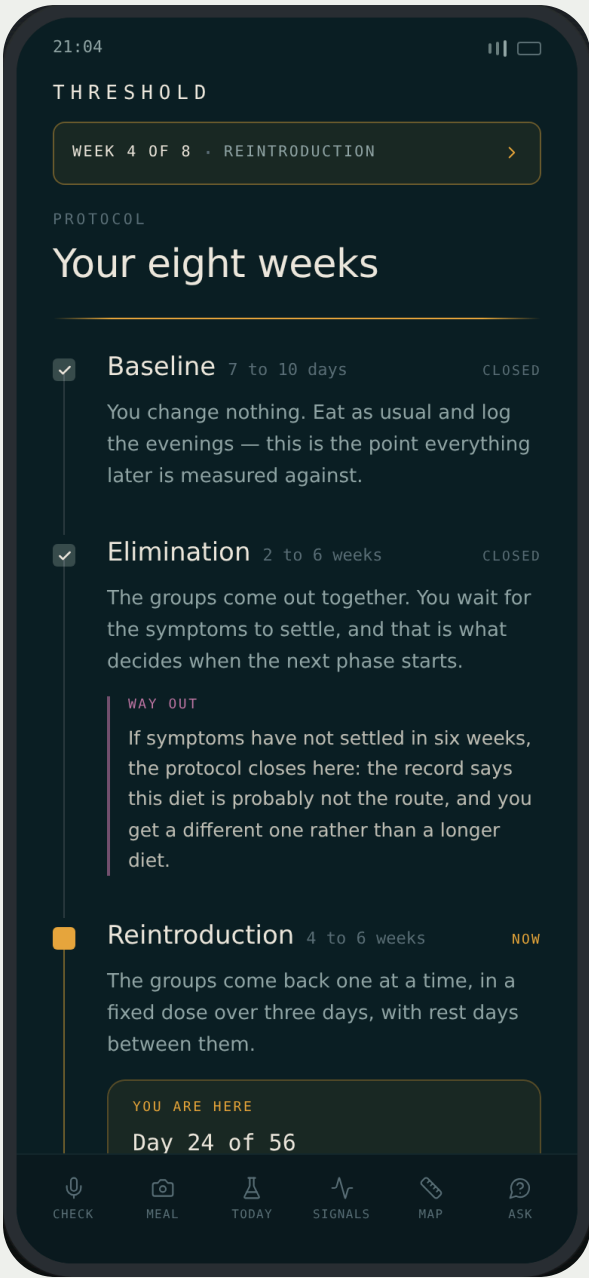
Внизу — строка о том, что это наблюдения участника, а не диагноз и не назначение.



Экран прототипа: восемь недель протокола

Четыре фазы с границами, текущая позиция днём из пятидесяти шести и правило выхода: если за шесть недель симптомы не осели, протокол закрывается здесь, а не продлевается.

Прогноз дан диапазоном — «4–6 недель», а не датой, потому что переход к следующей фазе решают симптомы, а не календарь.



Экран прототипа: день челленджа и искажающий фактор

Доза на сегодня, лестница из трёх дней и одна еда на весь челлендж — это и есть ведение, которого нет в дневниках.

Первый день помечен как не засчитанный: четыре часа пятьдесят минут сна накануне, и разделить дозу и ночь по этому дню нельзя. Предложено повторить группу.

